פרכוסים ואפילפסיה



מה זה פרכוס?

ההגדרות

פרכוס: שינוי זמני בהתנהגות או בהכרה, מפעילות חשמלית לא תקינה של המוח. **אאורה:** תחושה מקדימה (ריח שרוף, טעם מתכתי, הזיות). **אפילפסיה:** לפחות 2 התקפים שלא נגרמו בכוונה, או שלא נמצא להם גורם. פרכוס מגמילה מאלכוהול אינו אפילפסיה.

כמה זה נפוץ?

כ-**9%** יפרכסו לפחות פעם בחיים (חלקם פרכוס חום). רק **0.6–1%** חולי אפילפסיה. בגיל המבוגר גברים בסיכון מוגבר, והתמותה גבוהה מכלל האוכלוסייה.

מה קורה במוח?

כשל במעבר הדחף בקליפת המוח ← **סערה חשמלית**. הביטוי תלוי במיקום: באזור התנועה נראה תנועות, באזור הראייה הפרעות ראייה. בין הפרכוסים: חיים רגילים.

איך נראה פרכוס?



סטיית מבט או בהייה · חוסר הכרה או שינוי התנהגות קיצוני · תנועות לא רצוניות (חבלות) · אובדן טונוס (סוגרים) · טונוס מוגבר (נעילת לסת, **נשיכת לשון**, דימום מהפה) · קוצר נשימה, קצף.

מה גורם לפרכוס?

במוח: חבלת ראש, שבץ, גידול · **אספקה:** היפוקסיה, עלפון, היפוגליקמיה · הפרעות מטבוליות ואלקטרוליטים · תרופות, סמים, גמילה מאלכוהול · זיהום, חום, רעלת היריון · תורשה, אידיופתי.

בשטח: חשוב יותר מהסיבה המדויקת: לטפל בסיבוכים ולזהות גורם הפיך. **סוכר לכל מטופל מפרכס.**

סוגי הפרכוסים

חלקי · Partial
שקט וממוקד, פגיעה בחלק אחד של המוח. **פשוט:** בלי פגיעה בהכרה (רעד ביד, נימול, הזיה רגעית; ג'קסוניאני מתפשט בהדרגה). **מורכב:** עם אובדן הכרה, תנועות חוזרות (ליקוק שפתיים, לעיסה), לא זוכר.

כללי · Generalized
רועש, לרוב שתי ההמיספרות. **אבסנס:** ניתוק רגעי, ילדים 4–12, כ-15 שניות. **אטוני:** נפילה פתאומית, חבלות (קסדה). **מיוקלוני:** כיווצים קצרים, נשאר בהכרה. **קלוני:** רעידות לסירוגין. **טוני:** מתוח, כ-20 שניות.

גראנד מאל (טוני-קלוני): רוב המקרים בשטח. **קודם מתוח, אחר כך רועד.** סכנות: אפניאה, אספירציה, נשיכת לשון, ובעיקר היפוקסיה מוחית. פוסט-איקטלי ארוך.

שימו לב: כל פרכוס יכול להפוך לכללי ← עוצרים כל פרכוס מהר. הסכנה העיקרית: **אנוקסיה מוחית**.

סטטוס ופוסט-איקטלי

5 דק'	6%	15%
ברציפות = סטטוס	חוזר תוך 24 שעות	תמותה בפרכוס מתמשך/חוזר

סטטוס אפילפטיקוס (לפי האוגדן)

פרכוס **מעל 5 דקות ברציפות**, או פרכוסים עוקבים **בלי חזרה להכרה מלאה** ביניהם. רוב הפרכוסים נגמרים לבד תוך 5 דקות. בעד 30%: סיבוכים (חום גבוה, בצקת ריאות, הפרעות קצב, חסרים נוירולוגיים).

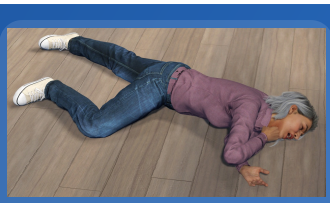
שימו לב: סטיית מבט קבועה, ולא חזר להכרה = **עדיין מפרכס**.

המצב הפוסט-איקטלי

אין פרכוס פעיל, וההכרה עוד לא תקינה: בלבול, תוקפנות, או עייפות וישנוניות; לפעמים סוגרים בסוף הפרכוס. דקות עד שעות. **הסיכון הגבוה ביותר לפרכוס חוזר.** שינוי באופי השלב = החמרה. **שיתוק טוד:** שיתוק או חולשת צד, עד 48 שעות.

מקור: התסריט של הסרטון (מצגת הקורס והאוגדן). הדף חומר לימוד ואינו מהווה תחליף לפרוטוקול מד"א המעודכן. איורים: מקוריים, בסגנון הסרטון. צילום המוח (מעובד): John A Beal, CC BY 2.5, ויקישיתוף. צילום נשיכת הלשון (מעובד): James Heilman, MD, CC BY-SA 3.0, ויקישיתוף.

פרכוסים ואפילפסיה



עמוד 2: עלפון או פרכוס · תשאול ותרופות · טיפול ופרוטוקול מד"א

דף סיכום · פודקאסטים קלוד

טיפול ופרוטוקול מד"א

בזמן הפרכוס

ABC · מרחיקים חפצים · ריפוד לראש · **על הצד** (היריון: צד שמאל) · חמצן לסטורציה **94–99%** · וריד, מוניטור, סוכר ואישונים. מוניטור, סטורציה ול"ד לא אמינים כשהגפיים מפרכסות.

שימו לב: לא מחזיקים בכוח, **ולא** מכניסים אצבעות או חפצים לפה (הקאה, אספיריציה).

אחרי הפרכוס

ABC · חבלות משניות · וריד ומוניטור: **טכיקרדיה פתאומית** יכולה לסמן פרכוס חוזר · סוכר, אישונים, אק"ג · מחפשים את הגורם · מרחיקים סקרנים ושומרים על פרטיות.

מד"א: פרכוס / לאחר פרכוס במבוגר (אוגדן עמ' 84)

1. גישה כללית · **השכב** על צידו ככל האפשר
2. **שקול** מתן חמצן · **התקן** עירוי IV/IO
3. האם חל שיפור? לא ← **תן** דורמיקום (הוראה, בלי ☎)
4. **חבר** מוניטור · **בדוק** מדדים · **בדוק** סוכר
5. חשד לאקלמפסיה? כן ← פרוטוקול רעלת היריון (משבוע 20 עד חודשיים אחרי הלידה)
6. לא ← פינוי דחוף לבית החולים הקרוב · מדדים כל 5–10 דק' · **שקול** דיווח מקדים

5 mg IV	10 mg IM/IN	5–10
דורמיקום	אין גישה IV/IO	דק': חזרה אם נמשך

אחרי דורמיקום וסוכר: מעקב ל"ד; יורד ← עירוי נוזלים (בדף התרופה: ל"ד נמוך וירידה בפרפוזיה = התוויית נגד). סוכר מתחת ל-60 mg% ← גלוקוז **25 גרם IV בריכוז 25%**, בדיקה חוזרת; אחרי 5 דק' עדיין נמוך ← מחצית המינון. ילדים: פרוטוקול נפרד לפי משקל.

עלפון או פרכוס? ותשאול

עלפון

בתנוחה זקופה · הדרגתי או פתאומי · לרוב בלי פציעה · סוגרים נדיר · **שניות, התאוששות מהירה**

פרכוס

בכל תנוחה · פתאומי · לרוב יש פציעה · סוגרים שכיח · **דקות, התאוששות הדרגתית**

מה שואלים (גם את מי שראה)?

תחושות מקדימות · דומה לאירועים קודמים? · אפילפסיה ברקע או במשפחה · תרופות ושינוי מינון · משך והתאוששות · אירוע אחד או כמה, מתי האחרון · רקע: סוכרת, היריון, חום, לב, גידולים · מוקדי? סוגרים? חבלה?

תרופות בית

נוגדי פרכוס: דפלפט, טגרטול, למיקטל, קפרה, טופמקס, דילנטין, לומינל (חלקן גם למצב רוח ופסיכיאטריה).

בנזודיאזפינים: ואליום (אסיבל), לוריוון, בונדורמין, נומבון, דורמיקום (יש גם ביתי, בעיקר בילדים).

3 דברים לזכור

1. **סטטוס: מעל 5 דק' ברציפות, או בלי חזרה להכרה מלאה בין פרכוסים**
2. **על הצד, ריפוד, חמצן 94–99%; לא בכוח ולא לפה**
3. **אין שיפור ← תן דורמיקום 5 mg IV (או 10 mg IM/IN); וסוכר לכל מטופל**

מקור: התסריט של הסרטון (מצגת הקורס והאוגדן). הדף חומר לימוד ואינו מהווה תחליף לפרוטוקול מד"א המעודכן. איורים: מקוריים, בסגנון הסרטון. איור התנוחה על הצד: Grummelbacke, CC0, ויקישיתוף.